

37 떨림/운동 이상

채점표 예시

병력 청취(주제 관련)	예	아니오
떨림/운동 이상의 발생 시점과 진행 경과에 대해서 물어보았다.		
떨림/운동 이상의 발생 부위에 대해서 물어보았다.		
떨림/운동 이상이 발생하는 상황(휴식, 물건을 집을 때 등)에 대해서 물어보았다.		
떨림/운동 이상의 양상에 대해서 물어보았다(규칙적인지, 꼬이는지, 춤추는 듯 하는지, 움찔거리는지).		
떨림/운동 이상의 악화/완화 인자(스트레스, 긴장, 음주)에 대해서 물어보았다.		
떨림/운동 이상 외의 파킨슨 증상(걸음걸이 변화, 표정 둔화)의 동반 유무를 확인하였다.		
갑상샘항진증 증상(더위불내성, 두근거림)에 대해서 물어보았다.		
두통이나 시야장애가 있는지 확인하였다.		
병력 청취(기본)	예	아니오
떨림/운동 이상을 유발하는 약물 복용에 대해서 물어보았다(정신과 약제, 항부정맥제, 항경련제, 위장관 운동촉진제 등).		
떨림/운동 이상의 가족력을 확인하였다.		
환자의 과거력(뇌혈관 질환, 두부 외상 등)을 확인하였다.		
음주력을 묻고 음주 시 떨림이 감소하는지 물어보았다.		
최근 커피나 녹차와 같은 카페인 음료를 얼마나 섭취하였는지 확인하였다.		

신체 진찰	잘함	보통	미흡
환자의 힘을 충분히 뻗 뒤 안정 시 떨림을 관찰하였다.			
양 팔을 앞으로 뻗은 자세에서의 손떨림을 확인하였다.			
원을 그리거나 이름을 쓰게 하여 활동 떨림을 확인하였다.			
갑상샘에 대해서 촉진을 시행하였다.			

소뇌기능검사를 실시하였다(Finger to nose, rapid alternating, romberg test, tandem gait).			
강직(rigidity)의 평가를 위해 팔관절의 수동적 운동을 시행하였다.			
보행을 시켜서 걸음걸이를 관찰하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
떨림/운동 이상의 가능한 원인과 감별을 위한 진단법에 대해서 설명하였다.			
유발 인자 회피 및 약물 치료에 대해서 설명하였다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

